

여성 건강격차의 구조와 정책 대응

오렌지국보건연구원 · 정책보고서 2025 - 14 · 2025 - 11 - 20

연구 배경

건강은 개인의 선택만으로 설명되지 않는다. 이 보고서에서 건강격차란 사회경제적 지위에 따라 체계적으로 나타나는 건강 수준의 차이를 뜻한다. 우연히 생긴 개인차와 달리 격차는 방향과 크기가 일정하게 관찰되며, 정책으로 줄일 수 있다는 점에서 다르다.

연구진은 여성가족실태조사 원자료와 건강보험 청구자료를 연계하여 분석하였다. 소득은 가구 균등화 처분가능소득 기준 5분위로 나누었고, 취업 상태와 돌봄 부담을 보정 변수로 넣었다.

소득계층별 건강격차

스스로 매기는 건강 평가에서 계층 차이가 뚜렷했다. 소득 1분위 여성의 주관적 건강 부정 응답률은 34.8%로 5분위 12.3%의 세 배에 가까웠다. 2분위 28.1%, 3분위 21.5%, 4분위 16.7%로 계단 모양의 기울기가 나타났다.

만성질환 유병률에서도 같은 방향의 기울기가 확인되었으나 기울기의 크기는 더 완만하였다. 진단받은 만성질환이 하나 이상인 비율은 1분위 47.2%, 5분위 38.4%였다.

돌봄노동자의 건강

돌봄을 직업으로 삼은 이들의 건강은 별도로 살펴야 한다. 영양보호사와 아이돌보미를 합한 돌봄노동자의 근골격계 통증 호소율은 61.5%였다. 부위별로는 어깨 42.8%, 허리 39.6%, 손목 31.2% 순이었다.

정신건강 지표에서도 차이가 나타났다. 돌봄노동자의 우울 위험군 비율은 22.9%로 전체 여성 취업자 14.1%보다 높았다. 근속 3년 이상 집단에서 26.4%로 더 높아, 노출 기간이 길수록 위험이 커지는 양상을 보였다.

정책 제언

격차를 줄이려면 치료 접근성만이 아니라 그 앞 단계를 함께 보아야 한다. 예방 중심의 접근이 사후 치료보다 비용 효과가 크다는 분석도 있으나 국내 자료로는 아직 확인되지 않았다. 국내에서 이를 검증하려면 최소 5년 이상의 추적 자료가 필요하다.

돌봄노동자에 대해서는 정기 건강검진과 작업환경 개선을 함께 묶는 방안을 제안한다. 검진만으로는 노출 자체가 줄지 않기 때문이다.